

2. Guide du formateur et manuel de l'étudiant

Examen clinique de l'abdomen normal

- Inspection générale du patient:
 - "ambiance" générale du patient (agitation, prostration)
 - pulsations, TA
 - rythme et amplitude des mouvements respiratoires
 - température
 - peau (ictère, angiomes stellaires, vergetures pourpres ...)
 - faciès (signes de dénutrition, de déshydratation, etc.)
 - langue (hydratation, papilles)

Inspection abdominale

- Morphologie générale :
 - plat vs distendu
 - symétrique vs asymétrique
 - cicatrices (cave laparoscopie parfois difficilement visibles)
 - hernies (ombilicales, inguinales, crurales)
 - veines superficielles
- Mouvements respiratoires (observer en même temps le faciès)
 - amplitude
 - symétrie
 - réaction à la toux

Auscultation

- *patience ! (attendre au moins 1 minute avant de dire qu'il y a absence de bruit)*
- bruits intestinaux (nombreux déplacement du stéthoscope sur l'abdomen inutile)
 - fréquence
 - tonalité (bruits "métalliques" ==> distension intestinale (cage de résonance))

Percussion

- légère si patient algique
- tympanisme (bruits aigus de tambour)
 - normal à l'épigastre (antre gastrique)
 - ailleurs signe distension gazeuse
- matité
 - signe liquide (ascite [déclivité], globe vésical, etc.)
 - permet mesure taille du foie, de la rate, d'une masse éventuelle

Palpation

- *toujours légère au début (commencer à l'opposé de l'endroit douloureux)*
- *tout particulièrement si douleurs aiguës*
- *une palpation brutale peut rendre l'examen difficile pour longtemps*

- Palpation **superficielle**
 - main à plat, doigts serrés
 - apprécier le tonus pariétal spontané et en réponse à la pression de la main
 - rechercher douleur localisée
 - rechercher une défense (peut être vaincue) ou une contracture (permanente)
 - en définir l'extension (contracture généralisée = "ventre de bois")
 - douleur à l'ébranlement
- Palpation **profonde**
 - recherche d'une masse
 - taille
 - consistance
 - forme
 - localisation
 - mobilité
 - pulsation (transmises ou de la masse elle-même)
 - aorte (perçue chez le sujet normal maigre)
 - taille des organes
 - rate : 2 méthodes complémentaires :
 1. décubitus dorsal ; une main postérieure dans la loge rénale, appuyant vers l'avant ; l'autre main antérieure sous le rebord costal ; faire inspirer profondément le patient ; le diaphragme fait descendre la rate qui est perçue par la main antérieure
 2. décubitus latéral droit (45-90°) ; même positionnement des mains ; même principe ; la main antérieure explore tout l'hypocondre gauche en inspiration profonde
 - foie :
 1. flèche hépatique : percussion descendante sur la ligne médio-claviculaire droite ; bord supérieur = limite entre la sonorité pulmonaire et la matité hépatique ; bord inférieur = limite entre la matité hépatique et la sonorité du côlon transverse ; distance entre ces deux bords = flèche hépatique (en cm.)
 2. débord xiphoïdien : percussion sur la ligne médiane = hauteur de la matité hépatique sous la xiphoïde

NB : l'examen des orifices herniaire et les touchers pelviens (rectal et/ou vaginal) sont rapidement mentionnés, mais non discutés ici (repris au séminaire 3)

2. Guide du formateur et Objectifs de la session

Première partie théorique

- DD des ictères (obstruction vs hémolytique vs insuffisance hépatocellulaire)
- Phanères et foie : ictère – angiome stellaire – ongles blancs – érythrose palmaire
- Hypertension portale (ascite et collatéralisation veineuse)

Deuxième partie en petit groupes :

1. Sémiologie des ictères :

Proposition pour un jeu de rôle :

- Ictère obstructif sur calcul résiduel ou néoplasie de la tête du pancréas

Histoire du cas:

Vous êtes un patient de 61 ans qui se plaint depuis une semaine d'un prurit généralisé. Vous avez remarqué que vos urines sont devenues plus foncées que d'habitude. Il y a trois jours, votre épouse vous a fait remarquer que vos yeux étaient devenus jaunes. Vos urines sont actuellement franchement brunes et mousseuses, alors que vos selles sont claires.

Lorsqu'on vous interroge plus avant, vous révélez que vous présentez depuis 3 mois une inappétence avec perte pondérale de 6 kilos et de vagues douleurs épigastriques en fond continu.

Dans vos antécédents personnels, on relève une cholécystectomie il y a 15 ans.

A l'examen, vous vous montrez légèrement apathique, mais bien orienté dans le temps et l'espace, sans troubles mnésiques. Vous présentez :

- *un ictère cutanéomuqueux associé à de nombreuses excoriations des extrémités*
- *des ecchymoses sur les avant-bras*
- *une absence d'ascite*
- *un foie de taille normale*
- *un Murphy négatif*
- *une rate non palpable*

Sur la base de ces trouvailles, faites discuter par les étudiants les éléments sémiologiques du diagnostic différentiel des ictères, en relevant notamment les éléments ci-dessous :

Ictère obstructif :

- prurit
- urines foncées, selles claires
- excoriations cutanées
- diathèse hémorragique
- absence d'encéphalopathie

Ictère sur cirrhose – ascite

- encéphalopathie
- foetor
- angiomes stellaires, érythrose palmaire et ongles blancs
- splénomégalie

2. Douleur biliaire simple ou compliquée : éléments du diagnostic différentiel

- *douleur biliaire simple (ancien nom = colique biliaire) :*
 - Siège : épigastrique, plus fréquemment que dans l'hypocondre droit.
 - Irradiations les plus fréquentes : hypocondre droit et en ceinture, épaule droite.
 - Type : ce n'est pas une colique, mais une douleur continue ! (d'où son nouveau nom de douleur biliaire simple)
 - Durée: < 6 heures.
 - Signes négatifs: absence de fièvre, de frissons.
 - Examen clinique: normal en dehors de la douleur provoquée (signe de Murphy).
- *cholécystite :*
 - persistance de la douleur > 6 heures (traduisant l'absence de désenclavement du calcul);
 - fébricule (traduisant l'apparition d'un syndrome inflammatoire);
 - empatement ou défense de l'hypocondre droit (traduisant l'existence d'une réaction péritonéale).
- *angiocholite (ou cholangite):*
 - fièvre + frissons (correspondant à l'infection biliaire, éventuellement au passage de germes dans la circulation);
 - ictère (traduisant l'obstruction de la voie biliaire principale, signe tardif);
 - anomalies des tests hépatiques (test le plus sensible pour la migration d'un calcul = élévation des transaminases (ALAT)).
- *pancréatite aiguë :*
 - douleur épigastrique ou péri-ombilicale d'apparition brutale, intense et constante,
 - irradiant volontiers dans le dos (caractère transfixiant) ou les deux hypocondres, puis souvent dans tout l'abdomen. Nausées+vomissements souvent incoercibles.
 - empatement ou défense épigastrique
 - anomalie des tests pancréatiques (lipase test le plus performant)

3. Objectifs de l'examen physique : insuffisance hépatique et hypertension portale

- Définition, technique de recherche et signification des signes suivants:
 - Hépatomégalie : (flèche hépatique > 13 cm sur la ligne médio-claviculaire);
 - atrophie hépatique (flèche < 8 cm) ; dysmorphie hépatique (discordance de taille entre les différents lobes).
 - Grosse rate (= rate palpable !).
 - Grosse vésicule biliaire.
 - Signes d'insuffisance hépato-cellulaire:
 - angiomes stellaires (description de la lésion élémentaire, zones électives d'apparition, disparition à la pression, diagnostics différentiels);
 - érythrose palmaire (éminences thénar et hypothénar, caractère pulsatile);
 - gynécomastie (parfois unilatérale, relation avec l'hyperoestrogénisme, causes médicamenteuses) ;
 - ongles blancs (disparition de la lunule).
 - Signes d'hypertension portale:
 - collatérales porto-systémiques (épigastriques, ascendantes, pathognomoniques de l'hypertension portale si on sait les distinguer des collatérales cavo-caves – dans les flancs) (pas toujours facile)
 - ascite (seul signe à citer = matité déclive)
 - Technique :
 - 1er temps: malade à plat ; percuter sur une ligne horizontale en partant de l'ombilic vers l'extérieur ; définir la limite entre la sonorité médiane intestinale et la matité latérale de l'ascite ; marquer cette limite sur la peau.
 - 2e temps: malade tourné à 30-45° ; rechercher la même limite du côté déclive ; si la limite s'est déplacée vers l'intérieur, on parle de matité déclive ; ce signe suggère fortement la présence d'ascite.
 - Sensibilité de cette recherche : faible ; environ 1 litre au minimum nécessaire ; mentionner la sensibilité supérieure de l'échographie (environ 300 ml.)
 - Signes de cholestase chronique:
 - prurit et lésions de grattage;
 - Signes d'encéphalopathie hépatique:

- apathie
- astérisis (ou flapping tremor) : il consiste en une brève relaxation du tonus musculaire (extenseurs du poignet) lors du maintien de la position main tendue. Il ne s'agit donc pas d'un tremblement. Se recherche en demandant au patient de garder les bras tendus élevés avec les doigts écartés pendant plus de 30 secondes, yeux fermés. Apparition à intervalles réguliers de mouvements alternatifs de rapprochement et d'écartement des doigts et de flexion et d'extension des poignets. Les 2 composantes de ce mouvement sont inégales : le rapprochement-flexion est rapide, l'écartement-extension est lent. Ces mouvements sont bilatéraux, asymétriques et asynchrones.
- foetor (odeur sucrée, légèrement fécale)
- coma hépatique (de l'apathie au coma, en passant par la confusion).

2. Guide du formateur et Objectifs de la session

Première partie théorique

- Définitions diarrhées et constipation
- Description de l'aspect des selles
- Bruits abdominaux (enregistrements)
- Examen herniaire ([vidéo](#))

Jeu de rôles

Sémiologie d'une modification récente du transit intestinal.

Vous êtes un patient de 60 ans, qui présente une alternance de diarrhée et de constipation depuis trois mois. Vous avez noté la présence de quelques selles noires, défaites et nauséabondes depuis quinze jours. Depuis 48 heures, vous n'avez pas eu de selles ni de gaz. Vous vous plaignez d'une distension douloureuse de l'abdomen et éprouvez des difficultés à vous alimenter (nausées).

Le commentaire de ce jeu de rôle doit amener à définir et discuter :

- la signification de modifications du transit intestinal
- la définition d'une occlusion intestinale
- la signification de différentes modifications de l'aspect des selles (ici, un méléna) :
 - Selles de couleur habituelle mais coiffées de sang : lésion anale (hémorroïdes)
 - Selles de couleur habituelle mêlée à du sang rouge : lésion recto-sigmoïdienne
 - Selles rouges avec caillots (hématochézie) : hémorragie aiguë en cours haute ou basse
 - Selles noires luisantes (méléna) : hémorragie digestive haute, parfois grêle ou même colique (caecum)
 - Selles couleur mastic : obstruction biliaire complète, insuffisance hépato-cellulaire
 - Selles jaunes-grisâtres, pâteuses, abondantes, flottantes : stéatorrhée
 - Selles en pétoles, dures : colon spastique
 - Selles " rubanées " (de calibre diminué) : évocatrices d'une sténose basse

Résumez les objectifs de la prise d'anamnèse du transit intestinal:

- Evolution générale du trouble du transit:
- nombre de selles par 24 heures.
- Caractère impérieux ou douloureux de l'émission.
- ténesme (sensation douloureuse de corps étranger intra-rectal) ;
- épreintes (douleurs coliques violentes qui précèdent l'exonération).
- Horaire matinal, post-prandial ou nocturne.
- Facteurs favorisants (alimentaire, émotionnel, thermique).
- Aspect des selles et présence d'éléments anormaux :
 - glaires (y compris dans certains cas de côlon irritable) ;
 - pus;
 - sang noir, sang rouge (cf plus haut)
 - graisses (correspondant à une stéatorrhée, définie comme l'élimination de plus de 7 g de graisse fécale par jour, souvent associée à une augmentation de la fréquence et du volume des selles) ;
 - présence d'aliments non digérés.
- Retentissement sur l'état général (asthénie, histoire du poids).
- Signes associés (douleurs, arthralgies, signes cutanés).

On doit aboutir aux définitions suivantes:

(Noter le caractère variable du temps de transit normal, variant entre deux selles par jour à une selle par deux jours).

- Diarrhée :
 - poids moyen > 300 gr/24 h
 - plus de 3 selles/24 h
 - (Intérêt de mesurer sur 3 jours pour écarter fausse diarrhée du constipé ou une incontinence fécale)
 - diarrhée aiguë : < 3 semaines
 - diarrhée chronique : > 3 semaines
- Syndrome dysentérique : fièvre – crampes abdominales – diarrhées avec présence de sang, de pus, de glaires
- Syndrome cholérique : diarrhées aqueuses très abondantes sans fièvre ni douleurs
- Constipation :
 - émission de 3 selles ou moins par semaine
 - selles dures
 - obligation de pousser lors de la défécation
 - importance de la recherche d'une **modification récente du transit**.
- Occlusion intestinale :
 - Ballonnement – vomissements (d'abord alimentaires, puis biliaires et enfin fécaloïdes) – douleurs en coliques (phase de lutte, disparaissent ensuite) – arrêt des gaz et des selles

Savoir distinguer les occlusions :

- hautes (" à ventre plat ") : les vomissements prédominent, une selle est encore possible (vidange du segment d'aval)
- basses : arrêt des gaz et des selles, ballonnement majeur, vomissements tardifs)

2. Guide du formateur et Objectifs de la session

1. Proposition pour un jeu de rôle

a) Descriptif

Le formateur joue un patient avec perforation ulcéreuse typique.

Il s'agit de Monsieur Billroth connu qui perfore :

- homme de 35 ans
- douleur brutale épigastrique en coup de poignard à XX h YY min
- « coupe la respiration »
- constante depuis
- continue
- très violente
- sans irradiation
- sans nausées, vomissements, troubles transit, fièvre, frissons
- exacerbées par la respiration profonde, la toux, les mouvements, les secousses du transport
- non calmée par prise de lait
- aucun antécédent identique
- antécédents de maladie ulcéreuse
- sensation de faim douloureuse, de brûlure épigastrique
- surtout fin d'après-midi et nuit (réveil à 02h)
- printemps, automne
- depuis plusieurs années
- ont répondu à la Ranitidine qu'il n'a pas pris de manière régulière
- a interrompu son traitement antibiotique d'éradication en raison d'une mauvaise tolérance après 48 heures

b) caractériser la douleur abdominale aiguë

- Début
- Progression, migration
- Caractère
 - coliques (le muscle lisse circulaire)
 - continues (le syndrome péritonitique)
- Intensité (échelle analogique)
- Siège
- Irradiation
- Facteurs déclenchants, aggravants, calmants
- Phénomènes transit bas (gaz, matières)
- associés :
 - nausées, vomissements
 - hoquet, éructations
 - troubles urinaires :
 - dysurie
 - pollakiurie
 - hématurie
 - dernières règles : quand, volume
 - pertes :
 - volume
 - fréquence
 - odeur
 - fièvre, frissons, transpiration
- Antécédents